

C'est la même image, avec des espaces rétrécis que celle-ci. C'est la même image. Ça, c'est le péritoine viscéral de l'estomac, feuillet gauche. Péritoine pariétale, péritoine viscérale, hépatique, droit. Petit épiplon, gastrohépatique, feuillet gauche. Ok, vous comprenez l'idée. Même schéma que je vais vous montrer dans un autre espace dimensionnel. Caroline, c'est quoi ce feuillet ? Péritoine viscérale gastrique, droit. Maintenant, je voudrais que vous soyez très précis. Feuillet droit du péritoine viscérale gastrique. Est-ce que vous vous situez là maintenant ? Je prends ces deux tissus. Et vous voyez ça. Je reprends ça. Et je le remets ici. Sur le feuillet droit du mésogastre apparaît une invagination. Un repli d'un péritoine qui monte. L'image qui est ici, elle va jusqu'ici. C'est-à-dire que cette petite poche, ce petit gant de toilette qui monte, on l'a coupé. Maintenant, j'explique un petit peu plus. À côté, j'ai mon foie. Moi, je suis costaud. Je me développe. Je grandis. Qu'est-ce qui fait qu'un organe se développe ? C'est qu'il reçoit de la nourriture. Et s'il reçoit de la nourriture, ça veut dire qu'il reçoit des informations par un champ vasculaire. Je me développe et là, ok, je dois me développer par là. Parce que je suis comme poussé par là. Le foie devient un moteur pour l'organisation de la cavité hépatos, gastros, pancréaticos, duodénales, etc. J'ai un mouvement hépatique qui organise le mouvement gastrique qui va organiser le mouvement de la rate linéale et derrière, pancréatico, mais par le mouvement ici, duodénale. C'est un mouvement dans un sens horaire. Maintenant, vous avez le tronc cœliaque. Le tronc cœliaque est un centre d'organisation vasculaire où, par le mouvement hépatique, va s'orienter... Le tronc cœliaque est un centre d'organisation vasculaire où, par le mouvement hépatique, va s'orienter... On voit l'artère stomacale, coronaire, et une artère très importante derrière qui est l'artère de la rate, l'artère splénique. Alors, vous imaginez, je suis l'estomac et ici, à côté, j'ai le foie qui, tout d'un coup, il grandit. Moi, je prends tout l'espace. mais comme j'ai une

branche qui me nourrit moins par là mais beaucoup plus à droite je me développe moi mon estomac il est là et en même temps j'ai cette petite poche ici et tout d'un coup je me tourne et ça amène cette petite poche qui était là à partir derrière comme ça il se développe derrière l'estomac et cette petite poche pousse fait un mouvement de rotation de mon estomac qui au départ était comme ça et tout d'un coup mon estomac il fait un mouvement comme ça j'ai cette poche rétro-gastrique qu'on appelle l'arrière-cavité des épiploons avec la porte d'entrée qu'on appelle le vestibule l'hiatus de Winslow la poche rétro-gastrique ma rate en arrière mon pancréas et ça vient comme ça ici et puis cette poche continue passe en dessous de l'estomac passe au-dessus du colon transverse n'oubliez pas j'ai quatre feuilletts qui vont se rejoindre pour aller former en avant le grand épiploon au-dessus j'ai mon cœur j'ai mes bronches j'ai mon foie vous devez le considérer comme le moteur de la cavité péritoniale dans son espace définitif c'est sa croissance vers la droite qui organise ce moteur mais juste avant j'avais cette petite poche rétro-gastrique sur le feuillet droit du péritone viscéral de l'estomac qui apparaît entre deux niveaux artériels par un espace de vie d'aspiration voyons ça non pas sur un plan comme je vous l'ai montré ici mais on va voir ça sur un plan transversal ce mouvement où j'ai uniquement tout le tissu endodermique avec mes poumons qui se développent et ces mouvements qui se régulent dans mon corps et ces mouvements qui s'organisent j'ai ce mouvement ici et j'ai mes bronches ici j'ai mon cœur en voie de développement qui est assez épais ça va orienter ma bronche souche gauche par ce mouvement elle se déplace vers la gauche et elle pousse mon poumon gauche et elle crée un espace pour que mon cœur descende enfin ça bascule et se développe sur un plan ventriculaire plus précisément avec un fulcrum sur mes aortes de se développer sur la gauche mon estomac qui est en dessous il tourne dans cette phase de développement derrière mon estomac ici j'ai ma

rate qui s'ouvre il y a une congestion qui se fait qu'est-ce que j'ai derrière ? j'ai mon pancréas qui était d'abord là il y a deux pancréas mais un qui suit le mouvement et commence à s'inspirer derrière aussi qui est le plus postérieur puis on va voir qu'il y a aussi toute l'organisation après duodénale, collique qui va s'organiser par rapport à ça le coeur il est très centré il y a une ouverture ce qu'on appelle le looping du coeur qui s'ouvre dans cet espace organisé par mon foie dans sa phase de développement sur la droite je vois mon foie et tout d'un coup ce foie hop il se développe très fort vers la droite et ça donne cette bascule sur son axe de mon estomac vers la gauche nerf vague qui était droite va devenir postérieur et le nerf vague qui était gauche va devenir antérieur on voit que ce mouvement de rotation de l'estomac amène une poche rétro-gastrique ici mon arrière cavité ici qui va derrière mon péritoine pariétale postérieure mon péritoine pariétale antérieure et là j'ai la continuité du développement de mon feuillet droit du péritoine viscérale gastrique et l'ensemble de ces feuillets ici vient se rencontrer à la partie inférieure de mon estomac ici pour former l'ensemble de ces tissus et qu'est-ce que l'ensemble de ces tissus va former le grand épiploon Le grand épiploon. C'est un tissu qui est, un, fait partie du feuillet droit du péritoine viscérale gastrique et de l'arrière du feuillet, puisque la rencontre de ce grand épiploon, c'est une rencontre de ces quatre tissus, qui va se rencontrer à la partie basse, en dessous de l'estomac et au-dessus du côlon transverse. Là, il passera derrière et en dessous. Donc, si tu veux, il fait ça. Là, on voit ce grand tablier épiploïque qui est relié à la fois avec ma rate, avec l'arrière de l'estomac, avec le pancréas, en relation avec le développement de mon foie, par rapport à l'artère hépatique qui va se développer. À quoi sert-elle, cette poche ? C'est l'articulation pour libérer un estomac. C'est l'espace le plus important pour libérer un estomac. C'est une poche d'adaptation. Votre estomac, il fait des mouvements comme ça. C'est une surface de

glissement. Vous avez à la fois une serreuse, une musculature longitudinale, vous avez une musculature circulaire, oblique. Rien que ces trois couches ici, longitudinales, circulaires, obliques. Donc, l'estomac, il peut brasser. Et il a besoin, dans sa fonction, de son métabolisme, dans son brassage de cet espace postérieur pour bien fonctionner. Ce grand tissu ici, qui connaît, c'est du péritone. Rappelez-vous, c'est une membrane qui contient une information de tous les organes, par son milieu liquidien, son interstitium. Mais en même temps, ce tissu contient une information de messagers lymphatiques de type B, T, M, avec une possibilité de mouvement et de déplacement dans la cavité péritonéale. C'est-à-dire que c'est un organe lymphoïde aussi. Si tu as une infection, tu as une petite sigmoïdite ou une appendicite, c'est un tissu vivant, il va venir ici, il va amener les copains, on va nettoyer le truc, il bouge. Quand vous prenez en conscience ce tissu qui est très superficiel, en fait, et que vous l'avez en résonance, vous avez de l'air, de l'air, de l'air, de l'air, de l'air, de l'air, de l'air, de l'air. Dans vos mains, toute l'arrière-cavité des épiploïdes, vous avez toute la connaissance du pancréas, vous avez la rate, vous avez l'estomac, vous avez le foie. Et il y a tout un mouvement, toute une histoire dans ce tissu. Où est son fulcrum embryonnaire du grand épiploïde ? Sur le feuillet droit, sur l'arrière-cavité et sur le feuillet antérieur. Et cette rencontre, ici, son fulcrum, il est... On sera dans la petite courbure, l'hiatus de Winslow. Le péritoine gastrique antérieur, l'estomac, le péritoine gastrique postérieur qui correspond à la paroi antérieure de la cavité, de l'arrière-cavité des épiploïdes, l'arrière-cavité des épiploïdes, ce qu'on appelle la poche rétro-gastrique de l'arrière-cavité des épiploïdes, la paroi postérieure de l'arrière-cavité des épiploïdes, le pancréas. Tout est organisé vers la horte. Et donc vers le cordon ombilical, la horte va ici. Et donc quel est le grand point d'appui ? Les piliers. Vous devez comprendre que tous les maisons ici sont tous

orientés et organisés autour de la horte. Maintenant, si on donne un point encore plus précis, on revient ici, on se dit, tiens, la horte passe ici. . Et si on va encore un peu plus précis, toute l'organisation de ce qu'on appelle le troncélic, avec l'artère coronaristomachique, l'artère hépartique-proc et l'artère splénique. Des ganglions neurologiques super importants, semi-lunaires, etc. Donc c'est vraiment un croisement d'informations qui va se retrouver là. C'est comme si j'étais sur un plan vasculaire tenu là. Mais le mouvement global reviendra vers le cordon ombilical. Pourquoi ? Parce qu'un peu plus bas, j'ai un autre axe, mais qui est plus en relation avec l'artère mésentérique supérieure et avec le système colique. C'est-à-dire que ça, on pourrait dire que c'est toute l'arrière-cavité des épiploons, et un peu plus bas, ce sera toute l'organisation du cadre colique qui se terminera sur le cordon ombilical, dont le vestige sera le diverticule de mesquelles. On va retrouver des points d'appui, ou ceux-là, où je recherche les champs vasculaires, primitifs, vitellins, ophalomésentériques, pour relancer la dynamique jusque dans le plan cérébral, sur un plan électrique vasculaire. Traiter un estomac, c'est lui redonner cet espace de glissement, aussi bien cette adaptation vis-à-vis de son oesophage et diaphragme, mais aussi bien la liberté de cette articulation. C'est-à-dire l'arrière-cavité des épiploons et aussi bien son plan immunitaire, sur un plan simplement du grand tablier. Ça commence à partir du 28ème jour. Une fois que j'ai l'intégration de mon cellulome externe en un cellulome interne. Un vieillard, on va retrouver son sécum dans son pantalon. La rotation continue toute la vie, le cœur continue toute la vie. On est tout le temps en mouvement. Au départ, c'est bouuuut, et puis pchhh. Donc ce processus, il ne s'arrête jamais. Donc bien comprendre que la membrane pharyncobasilaire, c'est une technique d'échange, aussi mécanique. Il y a différentes relations ligamentaires, pterygomandibulaire, stylo-hyoïdien. Donc vous commencez à

comprendre toute cette petite relation ici, entre les muscles, hyoïdien, stylo-hyoïdien, homo-hyoïdien, thyro-hyoïdien. L'importance de libérer. C'est là où on voit que l'hyoïde devient un point d'appui, qui soit en fonction de l'intégration, de l'information à la fois de la déglutition, de la mastication, comment tout ça s'intègre dans la bonne qualité de l'estomac. Ça veut dire que l'estomac commence par, aussi, une bonne mastication. La salive est le copain de l'estomac, parce que la digestion ne commence pas dans l'estomac, elle commence directement dans la bouche. Ça veut dire que tout ce qui est en IT aussi, amygdalite, pharyngite, peut être relié au plexus gastrique, au plexus mésentérique. Donc l'importance de prendre soin de cet estomac. L'estomac, il a besoin, pour sa bonne fonction, d'un diaphragme libre, de tous les diaphragmes libres. L'œsophage, n'oubliez pas, agit comme une corte qui se tend dans cet espace médiastinal. Donc les compensations vont se faire par le diaphragme, par ta colonne vertébrale, et par ces petits muscles de rouget qui... Donc apprendre à relâcher, à libérer, travailler cet espace. Il faut parfois, pas tout de suite traiter l'estomac, mais il faut enlever, détoxifier, réinformer le terrain. Essayer, si c'est possible, de dégager les stimulus nociceptifs. Vous voyez ce que c'est l'angle de His ? C'est un angle qui exprime les tensions intragastriques. On peut essayer de le travailler. On avait mis assis la personne, et je lui avais demandé de petit à petit d'aller et de réouvrir pour commencer à prendre conscience des muscles de rouget, de juvara, de cette tension, essayer de libérer l'espace œsophagien. Maintenant, dans ce traitement, je vous conseille de revenir et de rajouter cette poche rétogastrique, de libérer les côtes, de libérer l'espace d'adaptation de cet estomac. Si vous regardez cet estomac, il y a des zones qu'on appelle les zones du cardia, les zones du fundus, les zones du corpus, au niveau de l'entrium, du pylore, et on voit qu'il y a des cellules qui sont légèrement différentes, qui produisent des substances hormonales,

des substances liquidiennes. La gastrine se retrouve dans le péritoine du petit bassin aussi. Et très fréquemment, des problèmes au niveau de l'estomac, c'est une concentration, un déséquilibre entre ce plan hormonal que tu vas retrouver au niveau de l'estomac, mais qui est en fait influencé par le petit bassin et qui va se déplacer jusque sur le plan de l'estomac et qui va déstabiliser la qualité de l'estomac. Traiter un estomac, c'est libérer le petit bassin de la femme ou libérer la prostate. En fait, c'est des rééquilibrages dans le péritoine du petit bassin qui redégagent la fonction gastrique, la fonction subtile de la gastrine. Donc on est sur des plans moléculaires. Une femme qui a eu un avortement, mais dont la densité électrique n'est pas libérée. Elle n'a pas fait le deuil. Et donc il y a encore comme une histoire préconceptionnelle qui est fixée. C'est comme s'il y avait encore une entité symbolique qui n'était pas libérée. Parfois, il faut amener les gens à faire presque un rituel pour rendre à la Terre ce que l'univers voulait lui donner. Le pilore, c'est mieux de le manipuler deux heures après le repas parce que c'est là où il est le plus libre, c'est là où l'information chimique, physiologique... Vous avez cette relation avec le spédicule splénique, avec l'artère splénique, avec le pancréas. Regardez bien l'importance de cette relation avec la rate, avec la queue du pancréas, et avec le rein gauche et la surrénale. Ça, c'est vraiment une zone. Et qu'est-ce que j'ai derrière, là, entre les deux ? J'ai ma poche rétro-gastrique.